

BÁO CÁO SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

I. Phân tích Chính sách của Trường Đại học

1. Chính sách về AI tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - Trường Đại học Y Dược

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chưa ban hành văn bản quy phạm độc lập chỉ dành riêng cho việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh trong môi trường học thuật chuyên ngành Dược.

Tuy nhiên, lập trường của nhà trường được lồng ghép chặt chẽ trong các Quy định về Đạo đức trong Nghiên cứu Thử nghiệm Lâm sàng và Quy chế Đào tạo, đặc biệt chú trọng đến tính trung thực học thuật, tính chính xác của liều lượng và bảo mật dữ liệu cảnh giác dược.

- **Quan điểm chung:** Là một cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, nhà trường nhận thức được ứng dụng to lớn của AI trong việc tối ưu hóa thiết kế đề cương nghiên cứu, tra cứu tương tác thuốc và tổng hợp thông tin thuốc.
- **Nguyên tắc cốt lõi:** Báo cáo thực tập tại nhà thuốc/bệnh viện, tiểu luận chuyên ngành Dược lâm sàng và khóa luận tốt nghiệp phải là sản phẩm tư duy độc lập của sinh viên. Việc ứng dụng AI chỉ dừng ở mức độ công cụ tra cứu, sàng lọc tài liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc ban đầu.
- **Điều chỉnh qua Quy chế Gian lận:** Hành vi sử dụng AI để tự động viết phần biện luận lâm sàng, tự động đưa ra các khuyến nghị thay đổi phác đồ điều trị của dược sĩ mà không trích dẫn, hoặc lạm dụng AI để "bịa đặt" số liệu thử nghiệm sinh khả dụng, báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) giả mạo sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc với khung hình phạt cao nhất là đình chỉ học tập.
 - **Nhận xét:** Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Dược và xu hướng cá thể hóa liều lượng thuốc, chính sách của trường tập trung vào việc bảo vệ tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu dược học thực chứng. Điều này đòi hỏi sinh viên Dược khoa phải có kỹ năng kiểm chứng chéo (fact-check) cực kỳ nghiêm ngặt với các dược điển và cơ sở dữ liệu uy tín khi ứng dụng AI vào học tập.

II. Quy trình Sử dụng AI trong Nhiệm vụ Học tập

1. Nhiệm vụ Học tập đã chọn Nhiệm vụ:Viết phần Tổng quan Y văn (Literature Review) cho đề tài nghiên cứu Dược lâm sàng: "Phân tích hiệu quả và tính an toàn của phác đồ kháng tiểu cầu kép tối ưu hóa dựa trên kiểu gen CYP2C19 ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp sau can thiệp mạch vành qua da."

2. Ghi lại Prompt, Đầu ra và Quy trình Xử lý

Bước	Prompt đã sử dụng	Đầu ra của AI (Tóm tắt)	Đánh giá, Chỉnh sửa và Tích hợp
1. Xác định từ khóa nghiên cứu	"Đóng vai một chuyên gia Dược lâm sàng, hãy liệt kê 5 cụm từ khóa tiếng Anh và tiếng Pháp chuẩn xác nhất để tra cứu PubMed về chủ đề: cá thể hóa phác đồ kháng tiểu cầu kép dựa trên kiểu gen CYP2C19 sau can thiệp mạch vành qua da."	AI cung cấp danh sách từ khóa chuyên ngành. Tiếng Anh: Dual antiplatelet therapy, CYP2C19 polymorphism, acute coronary syndrome, clopidogrel resistance. Tiếng Pháp: Double antiagrégation plaquettaire, polymorphisme du CYP2C19, syndrome coronaire aigu.	Đánh giá: Từ khóa rất chuẩn xác với thuật ngữ chuyên ngành Dược lý di truyền và Tim mạch. Chỉnh sửa/Tích hợp: Tôi dùng trực tiếp chuỗi từ khóa này kết hợp các toán tử Boolean để quét trên PubMed, giúp định vị nhanh các bài tổng quan hệ thống (Systematic Review) chất lượng cao.
2. Tóm tắt bài báo dài	"Hãy tóm tắt phương pháp nghiên cứu và kết quả chính của abstract sau thành 3 gạch đầu dòng (dán nội dung abstract tiếng Anh về việc so sánh hiệu quả giữa Ticagrelor và Clopidogrel theo kiểu gen)."	AI tóm tắt: (1) Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 500 bệnh nhân. (2) Nhóm điều trị theo hướng dẫn kiểu gen giảm tỷ lệ biến cố tim mạch chính (MACE). (3) Không làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.	Đánh giá: Tóm tắt ngắn gọn, làm nổi bật được hai chỉ số quan trọng là hiệu quả lâm sàng và tính an toàn (nguy cơ chảy máu). Chỉnh sửa/Tích hợp: Tôi tự đối chiếu lại bài báo gốc để xác minh cỡ mẫu, tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân và các khoảng tin cậy 95% (95% CI). Sau đó tự diễn đạt lại bằng văn phong của mình vào khóa luận.
3. Cải thiện cấu trúc câu	"Diễn đạt lại câu văn sau cho mang tính học thuật dược khoa: 'Người bệnh có gen CYP2C19 chuyển hóa kém uống clopidogrel sẽ không có tác dụng chống cục máu đông nên dễ bị tắc mạch trở lại, cần đổi sang thuốc khác mạnh hơn'."	AI sửa thành: "Ở những bệnh nhân mang kiểu hình chuyển hóa kém (poor metabolizers) đối với enzyme CYP2C19, hoạt tính sinh học của clopidogrel bị suy giảm đáng kể, dẫn đến nguy cơ kháng thuốc và tăng tỷ lệ huyết khối trong stent; do đó, việc hiệu chỉnh phác đồ sang các chất ức chế P2Y12 thế hệ mới mạnh hơn	Đánh giá: Văn phong học thuật được nâng cấp vượt trội, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên ngành Dược lý lâm sàng. Chỉnh sửa/Tích hợp: Tôi tiếp nhận cấu trúc câu này, đồng thời bổ sung thêm nguồn trích dẫn từ hướng dẫn đồng thuận của CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium)

Bước	Prompt đã sử dụng	Đầu ra của AI (Tóm tắt)	Đánh giá, Chỉnh sửa và Tích hợp
		như prasugrel hoặc ticagrelor là một chỉ định lâm sàng thiết yếu."	để bảo đảm tính pháp lý y học.

3. Trích dẫn Minh bạch Tôi khai báo việc sử dụng AI trong phần "Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu" hoặc "Lời cảm ơn" của báo cáo theo chuẩn APA 7th:

Google. (2026). Gemini (Phiên bản Pro) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. <https://gemini.google.com>.

Được sử dụng để hỗ trợ chuẩn hóa thuật ngữ chuyên ngành Dược lý di truyền (Anh - Pháp) và tinh chỉnh văn phong học thuật trong chương Tổng quan Y văn.

III. Phân tích các Vấn đề Đạo đức

1. Ranh giới giữa Hỗ trợ hợp lý và Gian lận học thuật

Khía cạnh	Hỗ trợ Hợp lý (Sử dụng có Trách nhiệm)	Gian lận Học thuật (Lạm dụng)
Mục đích	Tối ưu hóa quá trình tra cứu y văn, vượt qua rào cản ngôn ngữ y khoa chuyên ngành (Pháp/Anh), tóm tắt thông tin thô.	Phó mặc việc phân tích cơ chế dược lý hoặc biện luận ca lâm sàng cho AI; né tránh việc tự đọc và hiểu bản chất tương tác thuốc.
Đầu ra	Danh mục từ khóa tra cứu, cấu trúc dàn ý tổng quan, gợi ý các câu văn diễn đạt trôi chảy. Sinh viên tự tiếp thu và tự viết.	Bản thảo báo cáo hoặc khóa luận hoàn chỉnh do AI tự viết từ đầu đến cuối. AI biến thành một "tác giả bóng ma" (ghostwriter).
Kiểm soát	Đối chiếu chặt chẽ với cơ sở dữ liệu y khoa uy tín (PubMed, Cochrane).	Sử dụng trực tiếp số liệu thống kê lâm sàng do AI tự "ảo giác" (hallucinate) sinh ra mà không có nguồn gốc.

2. Quyền sở hữu trí tuệ và Trích dẫn Trong ngành Dược, các phát minh, công thức và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng được bảo hộ bản quyền rất nghiêm ngặt. Khi AI tổng hợp thông tin, nó có thể trích rút dữ liệu từ các nghiên cứu trả phí của các nhà xuất bản lớn mà không tự động ghi nguồn. Nếu người học bê nguyên văn vào bài, họ không chỉ phạm lỗi đạo văn mà còn vi phạm nguyên tắc cốt lõi của Dược học thực chứng. Việc trích dẫn minh bạch giúp phân định rõ ràng giữa thông tin nền tảng do máy móc xử lý và bằng chứng lâm sàng được xác thực.

3. Tác động đến Quá trình học tập và Phát triển kỹ năng

- **Tác động tích cực:** Giải phóng sinh viên khỏi khối lượng công việc khổng lồ từ việc dịch thuật thuật ngữ và sàng lọc thủ công hàng trăm abstract, giúp họ có thêm quỹ thời gian tập trung vào việc phân tích chuyên sâu các case-study lâm sàng và tối ưu hóa liều lượng trên người bệnh.
- **Tác động tiêu cực:** Nếu lạm dụng, sinh viên sẽ bị suy giảm khả năng đọc sâu (deep reading) các báo cáo thử nghiệm lâm sàng phức tạp, mất đi tư duy phản biện và độ nhạy bén khi đối mặt với các phản ứng có hại của thuốc hiếm gặp ngoài thực tế.

IV. Bộ Nguyên tắc Cá nhân về Sử dụng AI Có Trách nhiệm (6 Nguyên tắc)

1. **Nguyên tắc Được học Thực chứng (Evidence-Based Pharmacy):** AI không phải là chuyên gia y tế hay dược sĩ lâm sàng. Mọi thông tin về liều lượng, chỉ định, chống chỉ định hay cơ chế tác dụng do AI đưa ra bắt buộc phải được đối chiếu lại với các nguồn dữ liệu gốc uy tín.
2. **Nguyên tắc Bảo mật Dữ liệu Lâm sàng:** Tuyệt đối không tải lên các hệ thống AI công cộng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, danh mục thuốc đang điều trị có kèm thông tin định danh cá nhân, hoặc dữ liệu giám sát ADR nội bộ chưa được mã hóa.
3. **Nguyên tắc Minh bạch Tuyệt đối:** Luôn chủ động khai báo rõ ràng tên công cụ AI, phiên bản sử dụng và mục đích hỗ trợ cụ thể ở phần Phụ lục hoặc Phương pháp nghiên cứu của bài tập.
4. **Nguyên tắc Công cụ Hỗ trợ:** Chỉ sử dụng AI làm trợ lý kỹ thuật (sửa lỗi chính tả, gợi ý từ đồng nghĩa, cấu trúc lại câu văn), tuyệt đối không để AI đóng vai trò làm người đưa ra quyết định chuyên môn hoặc tác giả chính của bài viết.
5. **Nguyên tắc Bảo toàn Tư duy Dược sĩ:** Văn bản cuối cùng phải thể hiện được năng lực tư duy, khả năng phân tích lợi ích - nguy cơ và logic biện luận lâm sàng của chính bản thân người viết, không lạm dụng văn phong rập khuôn của máy.
6. **Nguyên tắc Giới hạn Đánh giá:** Tuyệt đối không dùng AI để giải các bài tập tình huống lâm sàng (case studies), bài tập kê đơn hoặc các câu hỏi MCQ nhằm gian lận trong các kỳ thi đánh giá năng lực hay các học phần chuyên ngành.

V. Infographic: Sử dụng AI Có Trách nhiệm Trong Học thuật (Mô tả)

(Infographic được thiết kế với tone màu xanh ngọc biển - trắng chuẩn ngành Dược học)

- Tiêu đề: HÀNH TRÌNH ỨNG DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DƯỢC LÂM SÀNG

Phần 1: ĐÈN XANH (Nên làm - Hình ảnh viên thuốc/kính hiển vi)

- Tối ưu hóa từ khóa quét dữ liệu PubMed/Cochrane.
- Hỗ trợ dịch thuật tài liệu hướng dẫn điều trị (Guidelines) quốc tế.
- Tinh chỉnh cấu trúc và ngữ pháp văn bản học thuật.

Phần 2: ĐÈN ĐỎ (Không nên làm - Hình ảnh biên cảnh báo)

- Tải dữ liệu bệnh án lâm sàng thô của bệnh nhân lên AI.
- Sử dụng các thông số được động học "ảo" do AI tự tạo ra.
- Nhờ AI viết thay phần "Biện luận lâm sàng" và "Khuyến nghị của Dược sĩ".

Phần 3: QUY TẮC CỐT LÕI (Hình ảnh chiếc khiên bảo vệ)

- Verify (Xác minh): Đối chiếu độc lập với Dược điển và hướng dẫn điều trị chính thống.
- Cite (Trích dẫn): Khai báo minh bạch công cụ AI hỗ trợ.
- Think (Tư duy): Giữ vững lập trường và đạo đức của người thầy thuốc.



VI. Kết luận và Khuyến nghị

1. Kết luận

Việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào môi trường học thuật chuyên ngành Dược mang lại những tiềm năng đột phá trong việc xử lý thông tin thuốc và tối ưu hóa thời gian nghiên cứu, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn về đạo đức số và tính an toàn của dữ liệu điều trị. Việc phân định rõ ranh giới giữa "hỗ trợ công cụ" và "lạm dụng học thuật" là nền tảng để sinh viên duy trì sự liêm chính, bảo vệ giá trị cốt lõi của ngành Y tế.

2. Khuyến nghị cho các Trường Đại học Y Dược

- Ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyên biệt: Nhà trường cần xây dựng và phổ biến bộ cẩm nang chi tiết hướng dẫn cách thức sử dụng và quy chuẩn trích dẫn AI trong các báo cáo thực tập lâm sàng, khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành.
- Đổi mới phương pháp đánh giá: Chuyển dịch trọng tâm sang các hình thức thi vấn đáp lâm sàng trực tiếp, bài tập phân tích tình huống thực tế tại giường bệnh (OSCE), hoặc yêu cầu sinh viên thuyết trình bảo vệ phác đồ điều trị để đánh giá đúng năng lực thực chất.
- Lòng góp giáo dục đạo đức số: Đưa nội dung "Đạo đức dữ liệu số và Ứng dụng AI thực chứng" vào môn học Dược lâm sàng hoặc Phương pháp nghiên cứu khoa học ngay từ các năm đầu để định hình tư duy sử dụng công cụ đúng đắn cho sinh viên.